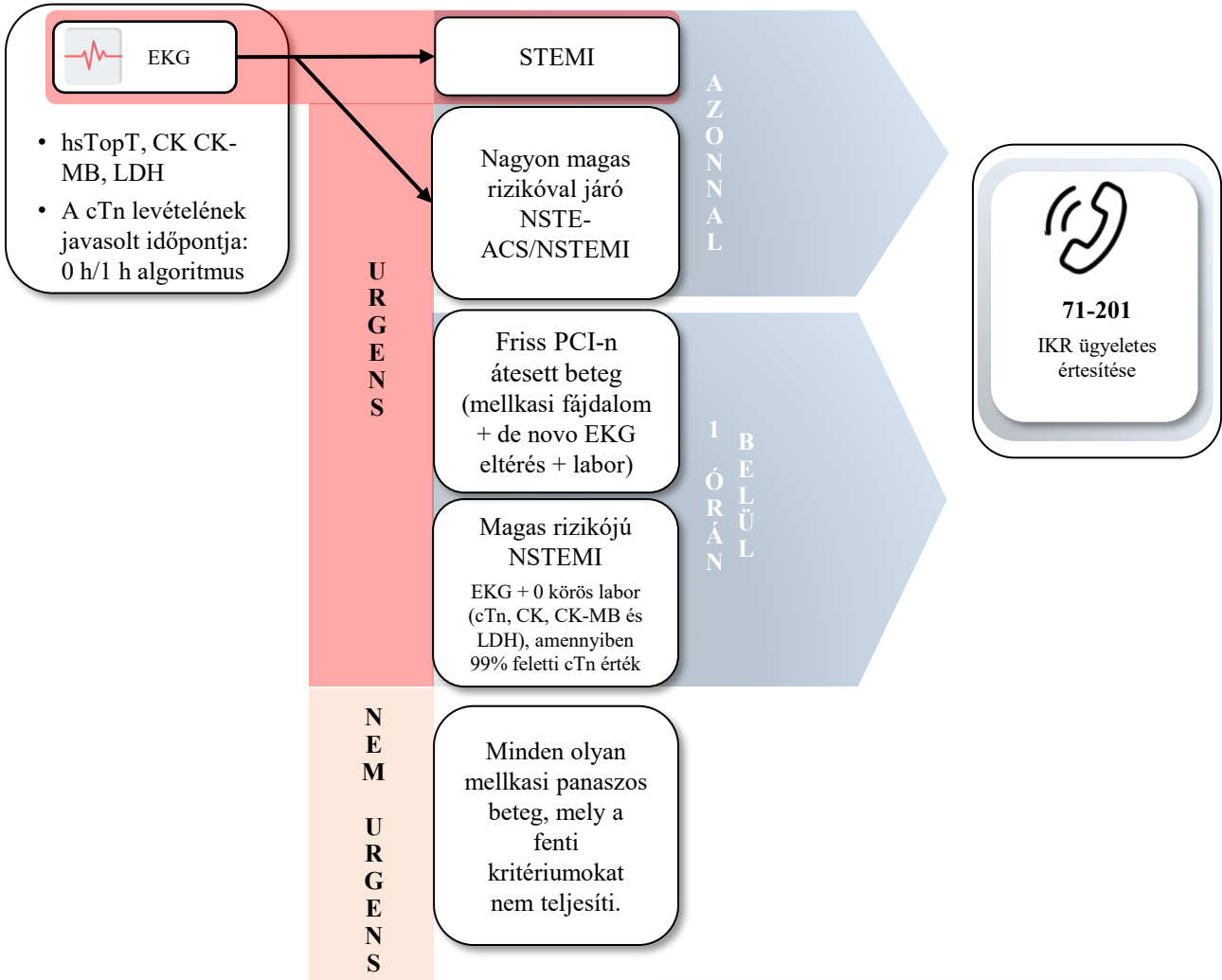


Az akut coronaria szindróma ellátása



Mellkasi fájdalom



Gyógyszeres kezelés és egyéb teendők

STEMI	NSTEMI
500 mg ASA + 600 mg clopidogrel p.o.	500 mg ASA p.o.
5000 NE Na-Heparin parenteralisan	

STEMI/NSTEMI esetében:

- Monitorizálás
- O2-szaturáció mérés → 90% alatt O2 supplementatio
- Sublingualis nitrát
- Nitropohl iv. adása perfúzoron akut balszívfél-elégtelenség esetén, amennyiben az SBP >120 Hgmm
- Szöveti típusú ACEi (perindopril/ramipril) p.o. (RR függően)
- I.v. metoprolol 10 mg-onként, amennyiben nincs akut szívelégtelenség (Killip stádium alapján), és SBP >120 Hgmm
- Rosuvastatin 40 mg p.o.
- Perzisztáló mellkasi fájdalom esetén iv. morfin, szükséges dózisban, 2 mg-os lépcsőkben adva

Reperfúziót követő ellátás elvei

STEMI / Nagyon magas rizikójú NSTEMI betegek 48 órát a coronaria őrzőben (CCU) töltenek, itt:

- Teljeskörű monitorizálás (HF vagy shock esetén invazív nyomásméréssel kiegészítve)
- 48 órán belül echokardiográfiás vizsgálat
- Napi szintű CK, CK-MB ellenőrzés mellett a CCU-ban aznap beosztott invazív kardiológus dönt a mobilizálási stratégiáról
- Fenntartó gyógyszeres kezelés beállítása
- Rizikófaktorok feltárása (teljes lipidpanel, HgA1C, BMI)